K

Ambulantní vyšetření kontrolní

Ze dne:

Zábělská Zdena *Dat. nar.:* **13.10.1961** *Kód poj.:* 111

Bydliště: **Ostrava**

Úvodní text: **Přichází k zahájení 1. pal. linie léčby fulvestrant + abemaciklib**

NO: Asi 1 rok ji trápí bolesti nad pravou lopatkou, pak levé lopatky, zhoršovalo se to. U PL dostala tabletky na uvolnění, nějaké injekce, pak se to hrozně zhoršilo. Od bolesti nyní užívá Biofenac - s efektem. Zažívací obtíže nejsou, nechutenstvím netrpí, nehubne.

Objektivní nález: Hmotnost [kg]: 57, Výška [cm]: 153, BMI: 24.35, Plocha těla [m2]: 1.54

Status praesens: ECOG PS: 1, bez klin. známek mozkových mts
spomalené psychomotorické tempo, lucidní, orientace správná, spolupracuje, eupnoe, bez cyanózy, bez ikteru, normální hydratace
HLAVA: poklep nebolestivý, zornice izokorické, správně reagují na osvit, hrdlo klidné, tonzily nezvětšené, jazyk vlhký, bez povlaku, plazí středem, chrup
KRK: souměrný, šíje bez opozice, štítnice nezvětšená, uzliny nehmatné, pulzace karotid symetrická, bez šelestu, žíly bez kongesce.
HRUDNÍK: souměrný, palpačně nebolestivý, stp. mastektomii vlevo, jizva klidná, pravý prs bez hmatné rezistence, axily, nadklíčky volné, bez LU, páteř poklepově bolestivá.
PLÍCE: poklep plný, jasný, dýchání alveolární, bez vedlejších fenomenu.
SRDCE: akce pravidelná, ozvy ohraničené, bez šelestu.
BŘICHO: v niveau, měkké, prohmatné, palpačně nebolestivé, bez patologické rezistence, peristaltika přiměřená, játra v oblouku., slezina nenaráží, tapott bilaterálně negativní,
Zevní genitál: nevyšetřen
VYŠETŘENÍ PER RECTUM: nevyšetřen
KONČETINY: hybnost v normě, klouby bez deformit.
DKK: třísla bez hmatných zvětšených LU, bez otoků, varixů a flebitid, pulzace hmatné symetricky do periferie.

Provedená vyšetření:

MMG 2/2025: vpravo bez nálezu
UZ prsu 2/2025: vlevo bez recidivy, bilat bez nového nálezu, axil a supraklavikulární LU nezvětšeny bilat.

Denzitometrie 29.9.2025: osteopenie LS páteře, v levé kyčli a v levém předloktí
UZ prsu 27.10.2025: vlevo bez recidivy, vpravo bez nového nálezu

RTG hrudníku, RTG plic 17.8.2026
Bránice je hladká, zevní siny jsou volné. Hily plicní cévní. Stín mediastina nerozšířen.
Plicní kresba přiměřená. Plicní křiídla jsou normálně vzdušná, bez ložiskových změn, bez infiltrace.
Srdeční stín nezvětšen. Def. spondyloza. Ostře ohraničené zastínění v oblasti VI žebra 13x5mm - pooperačně? kožní útvar?jine?
Sn. Th páteře:
Kyfoza hrudní je přiměřená, plynulá. Náznak esovité skoliózy. Výška obratlových těl v normě. Def. spondyloza.Meziobratlové prostory jsou přiměřené šíře. Pedikly ohraničené. Zobrazený skelet bez strukturálních změn.

Scinti skeletu 1.9.2026:
vidíme změny kostní struktury a akumulace farmaka meta typu-
temoroparetálně,parietálně lbka, horní Th dolní Th pánev vlevo kost kyčelní při SIS vpravo lopata kosti kyčelní ventrálně laterální část klavikuly vpravo
jinak prokazujeme změny kostní struktury a dep. farmaka/přestavba/degenerativní - ramena zápěstí +drobné klouby
páteř CC-max střední ,Th střední LS-max +SIS kyčle,kolena-,hlezna + nárty
Závěr:scintigram skeletu - od roku 2023 progrese mts do skeletu, degenerativní změny

---

PET/CT vyš. 14.9.2026
Závěr:
prokazujeme **FDG avidní generalizaci** základního onemocnění **do skeletu** ve smyslu převážně osteolytických MTS. **CAVE patol. komprese obratlového těla Th2, až tamtéž obraz vertebra plana, i s měkkotkáňovou složkou, která se mírně propaguje do páteřního kanálu a oboustranně foraminálně.**
V oblasti levého prsu, kde stp. mastektomii, bez PET/CT zn. lokální recidivy.

FDG avidita v oblasti sigmatu, kde zesílení stěny střevní a početné divertikly - nejspíše pozánětlivě - ale vhodná korelace s kolonoskopií k vyloučení event. TU. Uterus myomatosus.

EKG vyš. 16.9.2026
SR 67/min., PQ 150ms, QRS 90ms, QT 399ms, QTc 422ms,řevodní intervaly v normě, ST izoel., T pozit., bez známek iscehmie, bežz arytmií

Diagnózy:
C509 ZN - prs NS
C795 Sekundární ZN kosti a kostní dřeně

Závěr:
Ca mammae l.sin. z r.2023
pT2 N1mi(1+/3sn) M0
- stp. ME l.sin. 15.11.2023 Nem. FM
- histol. invazivního karcinomu NST G2 s in situ složkou DCIS G2, perineurální šíření +, lymfangioinvaze +
IHC: ER 100%, PR 75%, Ki-67 10%, HER-2/neu 1+ (HER2 low)
- stp adj RT 50Gy/ 25 fr KOC NJ 15.1.2024 - 22.2.2024
- adjuvantní HRT letrozol od 2/2024
- pro bolesti skeletu ad scinti **1.9.2026 - PD, mnohočetné meta skeletu**

- 1. pal. linie léčby fulvestrant od 7.9.2026
- PET/CT vyš. 9/2026 - generalizace do skeletu
- od 22.9.2026 abemaciklib

OA: HN, HLP, palpitace při izol. KES

Ošetření, léčba:
Fulvestrant 2x250mg i.v.

Nasazuji Verzenios 150mg 1-0-1 - začne užívat od 22.9.2026.

Tablety je možné užívat s jídlem nebo bez jídla. Během léčby nejíst grapefruity, pomelo, nepít grapefruitovou šťávou.
Není vhodné současné užívání s klaritromycinem a antimykotiky p.o. či i.v..

Při průjmu užívat Imodium 2mg cps., vstupně 2 cps., pak 1 cps. při každé další řídké stolici, maxim. 8 cps. denně. Při nedostatečném efektu přidá Smecta 1-1-1.

Pokračuje Calcichew 1000/800IU 0-0-1.

Chron. medikace: Nebivolol 5mg tbl 1-0-0
Od bolesti Biofenac 100mg 1-0-1, Novalgin 500mg tbl. 1-1-1.
Od PL nově Asentra 50mg 1-0-0.
Pozn. netoleruje tramadol - zvracení, slabost.

Doporučení:
Pacientka s Luminal A karcinomem levého prsu, HER2 low, stp. mastektomii vlevo 11/2023, stp. adjuvantní RT 1-2/2024, od 2/2024 adjuvantní HT s letrozolem.
Pro bolesti skeletu 9/2026 provedena scintigrafie, která prokazuje mnohočetné mts postižení skeletu.
Pro progresi onemocnění na léčbě letrozolem je do 1. pal. linie léčby indikován fulvestrant + CDK 4/6i abemaciklib = schváleno KOC komisí.
Také zažádáno o NGS vyš. = také schváleno KOC komisí.

Dnes 21.9.26 druhá aplikace fulvestrant 500mg i.m., další bude 6.10.26, poté á 1 měsíc.

Dnes Rp. Verzenios 150mg 1 bal.

Kontrola zde 6.10.2026 s odběrem KO, biochemie + Fulvestrant i.m. + 1. Bomyntra 120mg s.c. (dle výsledku stomatologie).
Při obtížích kontrola zde dříve, mimo ordinační hodiny na spádovém interním odd. s touto zprávou.

Nález na PET/CT vyš. bude prezentován na NCH semináři k posouzení indikace NCH intervence, jinak příště objednáme analgetickou pal. RT.

Jako vedlejší nález při PET/CT vyš. popisovaná FDG avidita v oblasti sigmatu, kde zesílení stěny střevní a početné divertikly - nejspíše pozánětlivě - ale vhodná korelace s kolonoskopii k vyloučení event. TU, proto **vystavuji žádanku na kolonoskopii - objedná se v Nem. Třinec.**

Pro pozit. RA objednáno genetické vyš.
Kontrolní PET/CT vyš. bude 12/2026 v NNJ.

Poznámka: Pacient/zákonný zástupce poučen o povaze onemocnění a léčbě, rozumí a souhlasí. Při odchodu je pacient ve stabilizovaném stavu.

7.9.2026
Sérum, plazma - zánět:
S_HSCRP: 4,8 mg/l [0 ... 5]
Sérum, plazma - sacharidy:
S_GLC: **6,0** mmol/l [3.9 ... 5.6]
Sérum, plazma - další vyš.:
S_BIL: 6,0 µmol/l [0 ... 21]
Sérum, plazma - dusik.metab.:
S_UREA: 6,1 mmol/l [2.9 ... 8.2], S_CREAE: 76 µmol/l [45 ... 84], S_URAT: 213 µmol/l [143 ... 339]
Sérum, plazma - enzymy:
S_ALT: **0,70** µkat/l [0.17 ... 0.58], S_AST: 0,37 µkat/l [0.17 ... 0.58], S_ALP: **2,52** µkat/l [0.58 ... 1.74], S_GGT: 0,51 µkat/l [0.1 ... 0.7], S_LD: 2,71 µkat/l [2.25 ... 3.55]
Krev - minerály, kovy:
S_NA: 142 mmol/l [136 145], S_K: 4,72 mmol/l [3.5 ... 5.1], S_CA: 2,49 mmol/l [2.2 ... 2.55], S_CL: 103 mmol/l [98 ... 107], S_OSMOLC: **296** mmol/kg [275 ... 295]
Renální funkce:
PT(KIDN)_EGFRCKDE: **1,14** ml/s/1,73 m2 [1.5 ... 99]
Krevní obraz:
B_LKC: 6,34 10^9/l [4 ... 10], B_ERC: 4,41 10^12/l [3.8 ... 5.2], B_HB: 139 g/l [120 ... 160], B_HCT: 0,413 1 [0.35 ... 0.47], ERC(B)_MCV: 93,7 fl [82 ... 98], ERC(B)_MCH: 31,5 pg [28 ... 34], ERC(B)_MCHC: 337 g/l [320 ... 360], B_RDW: 12,6 % [10 ... 15.2], B_PLT: 244 10^9/l [150 ... 400], B_PCDW: 0,0027 1 [0.0012 ... 0.0035], PLT(B)_MPV: 11,1 fl [7.8 ... 12.8], B_PDWSD: 14,2 fl [9 ... 17], LKC(B)_NEU: **0,734** 1 [0.45 ... 0.7], LKC(B)_LYMFO: **0,167** 1 [0.2 ... 0.45], LKC(B)_MONO: 0,087 1 [0.02 ... 0.12], LKC(B)_EOS: 0,009 1 [0 ... 0.05], LKC(B)_BAS: 0,003 1 [0 ... 0.02], B_NEU: 4,650 10^9/l [2 ... 7], B_LYMFO: 1,060 10^9/l [0.8 ... 4], B_MONO: 0,550 10^9/l [0.08 ... 1.2], B_EOS: 0,060 10^9/l [0 ... 0.5], B_BAS: 0,020 10^9/l [0 ... 0.2], B_NLR: **4,4** 1 [0 ... 4]
Onkologie:
S_CA153: **285,0** kU/l [1 ... 26.2], S_CEA: **29,1** µg/l [0.2 ... 4.7]
Primární vzorek (druh):
KREV: dodáno